Interview 1

JM arbeitet in der Abteilung Dermatologie seit 20 Jahren

1. Einleitende Fragen

Abteilung gewählt, weil: Ausbildung in Spital XXX, Hierarchie dort stellte für JM ein Problem dar.
Es war ihr gar nicht bewusst, was Dermatologie war beim Vorstellungsgespräch für die jetzige Stelle → Zufall.
JM war zuerst 15 Jahre auf Bettenstation und danach 5 Jahre auf Ambi (im Spital YYY).
Bettenstation war Hauptaufgabe: stationäre Patienten. / Ambi: wie Arztpraxis
Ausbildung in Frutigen: Pflegeassistentin (mit Vorprüfung) SRK, Schule war in Interlaken mit Blockkursen (4-6 Wochen) mit Praktikum im Spital.

Frutigen: War auf Medizin-Abteilung stationiert.

Momentan gesundheitliche Probleme, daher jetzt 50% Anstellung, sie arbeitete 15 Jahre lang 100%.

Am Anfang machte sie Nachtdienste (ist obligatorisch, wird im Arbeitsvertrag so festgelegt). Limite für Nachtdienste: 6 pro Monat. Es mussten ca. auch 6 Dienste pro Monat gemacht werden.

Arbeitszeiten im Ambi: 07:30-16:42, aufgrund gesundheitlicher Probleme 50% auf 4 Tage verteilt. Momentan keine Nachtdienste oder Wochenenddienste

Auf Bettenstation musste sie ständig einspringen, wurde von J.M als mühsam wahrgenommen. Jetzt im Ambi nicht mehr häufig einspringen.

Direkte Vorgesetzte: ist die Pflegedienstleitung (PDL). Normalerweise gibt es eine Stationsleitung (Gruppenleitung des Teams). Da Derma kleine Abteilung ist, gibt es keine Stationsleitung.
→ in anderen Abteilungen gibt es etwa dieselben Hierarchien

Klinikleitung (Arzt) ist höchste Position in der Klinik. JM hat gutes Verhältnis zu ihrem Chef (Klinikleiter), hat ihr auch schon eine Flasche Wein gegeben. Spricht sie mit Vornamen an, Sie ihn mit Nachnamen.

JM wird sehr gefördert, da man merkt, dass sie interessiert und engagiert ist. Sie sagt, dass PA (Praxisassistentin) auf der Hierarchiestufe eher tief ist.

Auf der Bettenstation war Hierarchiestufen bei Pflege: PDL -> Stationsleitung -> Pflegefachkräfte

PDL auf der Derma hat als Ausbildung dipl. Pflegefachfrau (organisiert Bettendispo, Kommunikation mit ärzten,…). PDL untersteht der Klinikleitung

Bettenstation: Pflege hat nicht viel zu sagen. Arzt sagt, wo es langgeht. Gewisse Sachen werden mit PDL oder Stationsleitung besprochen.

Ambi: Ärzte sind oftmals neu im Gebiet. Wundexperten (dipl. Pflegefachfrau) haben viel mehr Erfahrung. Daher hat man dort mehr zu sagen, auch als PA.

Chirurgen sind schwierig: brüsker, strenger → anderer Umgangston

Wenn es Problem bei/mit JM gibt, läuft dies über PDL

2. Motivation

Freundin des Bruders erzählte von ihrem Praktikum im Pflegeheim Belp. Es tönte für sie sehr interessant. Hat sich daraufhin dort beworben.

3. Hauptmotivatoren

Menschen zu helfen.
Auf Bettenstation hinterfragt: ist für Dermapatienten psychisch sehr belastbar, da chronische Erkrankungen sehr häufig waren. Sie hinterfragte sich, ob man ihre Arbeit überhaupt sieht oder diese etwas bringt. Wenn sie nicht da ist, würde man erst merken, was sie arbeitet. → Bettenstation ist undankbar, alle sind sehr gefrustet (Patienten) → sie setzten Therapie zuhause nicht fort → psychisch sehr belastende Situationen → hinterfragt, was Arbeit bewirkt, da keine Besserung
Die Situation der Patienten hat auf JM abgefärbt. Sie könnte sich auch nicht vorstellen auf eine Krebsstation zu arbeiten.

Berufsgruppen: Pflegefachkraft

PA: Pflegeassistentin (Pflegehilfe) SRK (gibt auch ohne SRK, ist weniger gute Ausbildung)

FaGe (Fachangestellte Gesundheit) : «man ist weder Fisch noch Vogel» → man darf mehr als PA machen, aber weniger als Pflegefachfrau

Dipl Pflegefachfrau

Pflegeexpertin

Expertin Pflege: höhere Fachschule

4. Aufgabenbereiche

Früher auf Bettenstation:

«gib mir, reck mir» → gibt mir, halt mir, …
Grundpflege → Körperhygiene
Medikation macht nur Diplomierte, wenn sie es PA übergibt zu bringen ist dies OK

Auf Ambi: Wundexperten assistieren (bei Vorbereitungen, OPs), dies auch bei Ärzten
Patienten Pflege → Wunde auspacken,…

JM hat Kompetenzen mehr als andere PAs. Sie macht die Patientenplanung aller Ärzte, org. arbeiten, Aufbieten der Pat.

- ➔ Sie wird als Organisator auf Ambi bezeichnet.
- ➔ Sie darf auch Arbeiten machen, die normalerweise als PA nicht gemacht werden, was von Norm abweicht

- ➔ Ihre Motivation wird vom Arbeitsumfeld honoriert

5. **Direkte Vorgesetzte** ist PDL → legt Regeln fest, mit ihr wird MAG (Mitarbeitergespräch) geführt

PDL auf Derma hat Mühe mit Vertrauen → sie will keine Stationsleitung, da sie nichts abgeben will

Der Vorgesetzte der PDL ist der Klinikleiter

6. **Identifikation**

Identifikation mehr mit Derma als mit Inselspital → Identifikation mit Fachgebiet

MAG, Regeln, etc. ist alles Abteilungsebene

Intern: im Inselspital ist alles je Abteilung geregelt → Chefin (PDL) hat sehr viel Spielraum

7. **Arbeitsumfeld**

a) Verhaltensvorschriften

Wir sind zertifiziert –> Name der Zertifizierung: Concret → sehr starke Vorschriften

Nicht das ganze Inselspital ist concret zertifiziert (nicht sicher)

Für jede Therapie in der Derma gibt es Handlungsanleitung → ist sicherheitstechnisch für Absicherung → dort sind Arbeitsschritte detailliert beschrieben.

Gibt für alle Tätigkeiten Handlungsanleitung : Tagesabläufe , auch für Infusionstherapien , Therapien

Es kommt häufig vor, das Personal davon abweicht

Gründe: Faulheit

Bei Anstellung muss man unterschreiben, dass man Kenntnis von Anleitungen hat und dies so berücksichtigen wird, dies Unterschrift wird auch erneuert (ca. jedes Jahr)

auch bei Nachtwache Kontrolle: musste auf Liste unterschreiben, ob Arbeit gemacht wurde

Regelmässig wird man geprüft: e.g. wo die Anleitungen abgelegt sind, was darin enthalten ist

- ➔ Wird von PDL oder Expertin Pflege geprüft (von normaler Pflegefachfrau nicht, nur von sehr ambitionierten)
- ➔ Gibt keine Sanktionen, wenn man davon abweicht → es gab immer wieder Fälle, bei denen davon abgewichen wurde (z.B. schlief einer während der Arbeitszeit im Patientenbett)
- ➔ JM ist der Meinung, es gibt zu wenig Sanktionen. Dies frustriert sie extrem
- ➔ Fehler sind menschlich, aber oftmals wird es aus Faulheit nicht gemacht
- ➔ Sie hat Gefühl, dass die PDL die Führungskompetenzen fehlen
- ➔ Regeln und Prozessdokumentationen werden von ihr als sehr hilfreich empfunden. Sie geben J.M. Sicherheit. → werden nicht als einschränkend wahrgenommen

c)

Entscheidungsspielräume sind für JM sehr gross. Ist normalerweise als PA nicht so. ist bei ihr so, da sie schon sehr viel Erfahrung hat. Man weiss von ihr, dass sie sehr gewissenhaft ist. Zudem wurde sie auch schon sehr oft geprüft → ihre Kompetenz ist allen bewusst

- ➔ Sie hat Angst, dass sie Fehler machen könnte, da sie bei administrativen Tätigkeiten (Medis bestellen,…) sehr viele Autonomie und Verantwortung hat
- ➔ Ihre Kompetenz und Gewissenhaftigkeit werden sehr wertgeschätzt von der Klinik
- ➔ Da alles genau dokumentiert wird, gibt ihr Sicherheit
- ➔ Die gesamte Tätigkeit wird genauestens dokumentiert. Ist der PDL sehr wichtig. JM ist dies auch sehr wichtig
- ➔ Diese Dokumentation ist von der PDL gewünscht. Ev. anderen PDLs nicht so wichtig → wird auf anderen Abteilungen ev. nicht so genau dokumentiert

e) **Kennzahlen**

auf Abteilungsebene:

Planungssystem: ist der Person zugeteilt

z.B. wenn 2 Wundexperten da sind ist Anforderung, dass JM für beide den ganzen Tag Patienten plant.

Dort ist ersichtlich, wie hoch die Patientenanzahl ist. Dies wird monatlich diskutiert.

Gibt keine Vorgaben für Patientenzahlen → Idee: jeder Tag muss gefüllt sein, von morgen bis abends

- ➔ Die Statistik ist die Vorgabe (MIS Reporting)

Auf Person bezogen:

Sie hat das Gefühl, das sie die einzige ist, die nicht kontrolliert wird. Ev. liegt dies daran, dass sie auf der untersten Lohnstufe ist

PDL geht am Morgen zu anderen Dipl., was sie am jeweiligen Tag machen. JM wird das nie gefragt. (wenn bei der Planung nichts geplant, wird dies gemacht, sonst nicht)

Liegt ev. daran, dass man ihr vertraut. → die anderen nehmen diese Kontrolle als fehlendes Vertrauen wahr. Sie wäre froh, wenn man sie fragen würde.

Für J.M gibt es keine spezifischen Kennzahlen. Sie muss einfach den Plan am Laufen halten.

Es gibt ein System, bei dem **Patientenzufriedenheit** erhoben wird.

Ambi: Immer bei Fallabschluss eines Patienten wird ein Fragebogen gegeben → kann ausgefüllt werden wenn man will, ist anonym

Auf Bettenstation wurde dies beim Austritt gemacht

- ➔ Dieses Feedback wird oftmals gegeben, Fragebogen wird oft von Patienten ausgefüllt
- ➔ Früher wurde vermehrt auf dieses Feedback eingegangen. Heute versandet es

Sicherheit:
immer, wenn ein Fehler passiert, muss man dies in System erfassen → dort wird Fehler ausgewertet

- ➔ Fehler müssen gemeldet werden
- ➔ Neu bekommt man Nummer: kann Fehler dann so verfolgen

Raport: einmal monatlich

Gibt einen übergeordneten für Team und einen für die Planer (alle 2 Monate)

Dort ist PDL dabei, ausserdem die Pflegefachkräfte, die an diesem Tag anwesend sind. Selten auch Controlling, Klinkleiter, Sekretärin

f) Ziele

Hauptziel, dass für JM gesetzt wurde: dass alles rund läuft

- ➔ Sie hat das Gefühl, man könnte mehr rausholen

MAG: einmal im Jahr
-- > wird von niemandem bevorzugt

Ablauf: Fokus liegt auf:

- Sozialkompetenz (Umgang mit Patienten und Team)
- Fachkompetenz
- Persönliche Kompetenz

Bewertung: A-E
A: erhält man nur, wenn man überqualifiziert ist –> erhält sozusagen niemanden
B: sehr gut
C: …

Am Anfang ihrer Anstellung:
musste sagen, wo man sich sieht, und Vorgesetzte sagt anschliessend, wo sie einem sieht.
die letzten zwei Jahre wurde nicht mehr gefragt, wo man sich sieht, sondern nur noch gesagt, wo man gesehen wird

Bei Beurteilung (MAG) werden auch andere Meinungen berücksichtigt. Wenn Feedback über jemanden erfolgt, notiert PDL dies sich über das Jahr verteilt für das MAG

MAG basiert auf Einschätzung des Vorgesetzten (PDL) → J.M. hat das Gefühl, ihre PDL hat eine gute Menschenkenntnis, geht sehr auf einem ein

J.M wurde keine Veränderungsmöglichkeiten vorgeschlagen. → sie macht ihre Arbeit sehr gut.
Anderen wurden Kommunikationskurse,… vorgeschlagen → dann werden Rückstufungen bei der Einschätzung im MAG gemacht → kommt z.B. von B ins C

In MAG werden Ziele für das nächste Jahr vereinbart → es werden konkrete Ziele gefordert

Bei ihr für das nächste MAG:

- 10-20% Stellenprozenterhöhung
- Patientenzahl erhöhen → dass mehr Patienten generiert werden können → ev. interne Kurse besuchen
- Keine Krankheitsausfälle → Gesundheit erhalten
- Weiterbildung wird ihr vorgeschlagen → z.B. zu FaGe

Der PDL der Derma sei persönliche Kompetenzen sehr sehr wichtig

Vergütung:

Fixgehalt, gibt kein Bonus

Sie macht spezielle Arbeiten → es wurde einmal davon gesprochen, dass sie ev. dafür speziell vergütet wird, wurde so nie gemacht

Reka-Checks → 3% von etwas (Ertrag?)

Löhne von anderen sehr unterschiedlich (bedingt durch Tenure, Ausbildung, Position,…) → sie hat noch nie nach einer Lohnerhöhung gefragt.
Gehaltserhöhung: ist Entscheidung der PDL → ist Tabuthema, niemand spricht darüber

Es gabt immer im April ein Brief: aufgrund Ihren guten Leistungen hat Pflegedienstleitung entschieden, sie bekommen x% mehr pro Monat → dies machte 30-60 CHF aus
dies hat bisher jedes Jahr stattgefunden (Ausser bei längerer Abwesenheit aufgrund Krankheit)
→ sie hat das Gefühl, dass diese Erhöhung von der Leistung abhängt
J.M wäre sehr dankbar für einen Leistungslohn

Diese Erhöhung stellt nicht wirklich Anreiz dar → ist zu tief, trotzdem freut es einem, dass Leistung anerkennt wird.

Lohn von J.M.: bei 50%: 1800.-

Zufriedenheit mit Lohn:

Derma zahl sehr schlecht im Vergleich mit anderen Kliniken des Inselspital

Frustration, da dipl. Pflegefachfrau mit 5500 Lohn ein Minimum leistet. Sie dagegen zeigt grossen Einsatz und verdient so wenig im Verhältnis.
Sie ist sehr dankbar für ihren Lohn. Vor allem dass sie so viele Kompetenzen hat

Unfair ,dass sie so viele Aufgaben erledigt und so wenig verdient

Weiterbildung

3 Tage pro Jahr bezahlt für Weiterbildungen, jeden Donnerstag intern, Feuerwehr, …

- ➔ Wird sehr gefördert

Bei den 3 Tagen: Lohn wird bezahlt und Kosten für Weiterbildung werden übernommen.

Letzte Jahr hat JM keine Weiterbildung besucht. Hat sich nicht angemeldet, dass sie das Gefühl hatte, sie hat keine Zeit. Es gabt keine Probleme deswegen (Weiterbildungen sind nicht zwingend, meldet sich selbstständig dafür an, wenn man möchte). PDL wies sie darauf hin, dass sie dies noch zu gute hätte

ES wird auch sehr gefördert, dass sie sich weiterbildet, ev. zu FaGe
→ wurde JM schon vermehr vorgeschlagen, sie solle doch eine weitere Ausbildung machen.

Chefin (PDL):

Es wird oft betont, dass Patientenzahlen stimmen müssen → es müssen alle ausser J.M rechenschafft über Arbeit ablegen. → wenn freier Slot ist, muss dies begründet werden. Wenn ganzer Tag verplant ist, wird nicht nachgefragt

Dies wird von Kollegen auch kritisiert → Wahrnehmung von ihnen: kein Vertrauen da von PDL

Stressoren bei Arbeit:

- Wenn Organisation des Tages schlecht aufgebaut ist: im Ambi ist Zeit sehr wichtiger Faktor (da wie Arztpraxis) → wenn 40min geplant, kann nur 20min abgerechnet werden (Limitationen Tarmed)
- Wenn nicht optimal vorbereitet ist, gibt es sofort Verzögerungen für den Arzt
- → Zeitdruck ist Hauptquelle von Stress
- Patienten reklamieren, wenn man Verzögerungen hat
- Wenn etwas nicht vorbereitet ist, was jemand anderes erledigen müsste, gerät man dadurch in Zeitdruck
- Wenn schlecht geplant wurde, gibt es auch Zeitdruck
- Bei Scherzen etc. von Patient kein Stress, da man ihnen sehr schnell und effektiv helfen kann
- Missachtung der Abläufe von anderen, Faulheit von anderen
- Keine fixe PA am Nachmittag (JM arbeitet jeweils immer Vormittags), da diese von Station geholt wird → Fluktuation ist schwierig (immer andere PA von Station)

Zufriedenheit kommt durch:

- Man kann den Patienten helfen
- Ergebnis der Behandlungen → wenn man Wirkung der Behandlung sieht
- Impact der Arbeit

Kündigungsabsichten:

- Inselspital: wenn JM sich vorstellt zu kündigen, bekommt sie Heimweh
- Wenn JM auf die Bettenstation zurückmüsste, würde sie den Beruf wechseln → extremer Zeitdruck
- 100% könnte sie so nicht arbeiten
- Gute Rückmeldung von Ärzten, PDL,… senken Kündigungsabsichten

Interview 2

KH ist dipl. Pflegefachfrau in Ausbildung (Fachhochschule)

Diese dauert 3 Jahre, danach hat man den Bachelorabschluss → Tertiärstufe

Pro Jahr hat man 3-4 Monate ein Praktikum in verschiedenen Institutionen (ein Praktikum muss in einem Pflegeheim stattfinden)

Erstes Praktikum von KH war in Neurologie im Spital AAA

Jetziges Praktikum ist in BBB: innere Medizin → Vollzeit, 42h Wochen

Vorher Berufslehre als MPA (medizinische Praxisassistentin) in Kinderarztpraxis

Arbeitszeiten:

- Als Einführung 2 Wochen lang Tagdienst von 06:45-16:00
- Nach 2 Wochen hat man alle Dienste aus Nachtschicht
- Spätdienst dauert bis 23:30

Einspringen:

- In Ausbildung ist man «geschützt» vor dem Einspringen
- KH betrifft es nur 2-3 im Monat
- Persönliche Grenze für KH: 1x pro Woche wäre zu viel
- Stationswechsel ist am schwierigsten, ist am wenigsten beliebt (z.B. muss man auf chirurgische Station gehen, ist von der Ausbildung her kein Problem, da man generalisiert ausgebildet wird)
- Problem, wenn man auf andere Station kommt: wird als volle Arbeitskraft gerechnet, aber kennt Ablauf, etc. nicht → ist grosses Thema unter Pflegekräften

Motivation zu Pflegeberuf:

- KH wollte schon immer im medizinischen Bereich arbeiten
- Berufslehre mit 15 Jahre gestartet → als MPA sehr wenig Weiterbildungsmöglichkeiten, man ist zu wenig nahe am Menschen
- Begleiten der Patienten in verschiedenen Situationen gefällt ihr sehr. Helfen nicht als wichtigste Komponente. Helfen kommt vom Arzt her, als Pflegefachfrau begleitet man eher
- Man kommt in Situationen, in denen man sonst nie so nahe an einen Menschen kommen kann
- Mit Bachelor hat man danach sehr viele Weiterbildung- und Aufstiegsmöglichkeiten

Antreiben:

- Menschen begleiten, nahe an Menschen sein.
- Pflege erhält sehr viel Dankbarkeit von Seitens Patienten
- Vor allem von älteren Menschen sehr viel positives Feedback → viel mehr als in anderen Berufen

Politische korrekte Ausdruck: Pflegefachperson, Pflegefachkraft → darin alle Ausbildungen enthalten

Aufgabenbereiche:

- Sehr viel Körperpflege, da sehr viele ältere Menschen auf innerer Medizin
- Medis, Infusionen verabreichen
- Blutdruck messen
- Verbände
- Visite mit Arzt auf innerer Medizin sehr wichtig, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch
- Visite wird auf jeder Station anders gehandhabt → Pflegefachperson ist immer dabei mit Arzt, da Pflegefachperson den Patienten am besten kennt. FaGe in Ausbildung sind bei dieser Visite nicht dabei, ausgebildete FaGes schon

Abteilung:

- Sehr breites Spektrum auf innerer Medizin

Angehörigenbetreuung:

- Ist sehr wichtig
- Als MPA hatte dies schon sehr grossen Stellenwert (Eltern betreuen in Kinderarztpraxis)
- Ist sehr anspruchsvoll

Organisationsstruktur:

- Direkter Vorgesetze: Stationsleitung
- KH hat auch noch Berufsbildner, der für Ausbildung zuständig ist
- Über Stationsleitung ist PDL (Pflegedienstleitung)
- In AAA gibt es noch Departementsleitung (zwischen Stationsleitung und PDL)
- In YYY: PDL ist Mitglied der Geschäftsleitung
- In anderen Spitälern ist PDL auch oftmals den Ärzten unterstellt

MAG:

- Wird von Berufsbildnerin durchgeführt (sie arbeitet auch im Spital, ist aber nur als Berufsbildnerin) Sie begleitet einem den ganzen Tag
- Nach Ausbildung ist MAG mit Stationsleitung

Identifikation:

Mehr mit Abteilung als mit dem Gesamtspital → ganz klar
Identifikation entsteht durch Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, daher Abteilung

Steuerungsmechanismen:

Verhaltensrichtlinien:

- Grundlegende Richtlinien: Haare zusammenbinden, kein Nagellack,…
- Aufgaben, die an Tag erledigt werden müssen, wird von Stationsleitung überprüft. Dafür gibt es Dokumentationssystem: Checkliste auf den Patienten bezogen → muss abhäkeln, was erledigt ist
- Monitoring der Stationsleitung ist eher weniger. Ist viel stärker untereinander im Team gegeben → da sonst die Ablösung der Schicht das für einem nachholen/nacharbeiten muss → gegenseitige Kontrolle
- Gegenseitige Kontrolle wird nicht negative aufgefasst → sie ist sehr wichtig: aufgrund des Zeitruckes ist diese Kontrolle nötig
- Richtlinien werden als Hilfe wahrgenommen, jedoch sind sie generalisiert und werden dadurch nur ausnahmsweise als einschränkend wahrgenommen

Zeitdruck:

- Geschützt davor, da in Ausbildung
- Wird als grösster Stressor wahrgenommen
- In Schule lernt man, was und wie man alles machen kann, die Umstände in der Praxis lassen dies jedoch nicht zu → ist sehr frustrierend
- Frustriert auch in der Schule: man weiss von Anfang an, dass es nicht umsetzbar sein wird in Praxis → hinterfragt: wieso wird es nicht praxisnaher gemacht

Freiräume:

- Gibt Plan, aber nebenher hat man sehr viele Freiheiten
- Kann auch Interventionen in Prozess aufnehmen, z.B. wenn jemand eine Entzündung an der Hand hat, kann man Quarkwickel machen. Dies muss dann von Ablösung weitergeführt werden –> hat somit Autonomie, welche von KH sehr geschätzt wird

Kennzahlen:

- In YYY: Patienten werden in 1-3 eingeteilt: 3 Benötigt sehr viel Pflegeaufwand, 1 ist selbstständig und benötigt nur Mediüberwachung,…
- Ist von Berufsbildnerin vorgegeben, wie viele Patienten man übernehmen darf
- Stationsleitung macht Patienteneinteilung
- In Ausbildung hat man ca. 5 Patienten pro Tag
- CIRS: Fehlermeldeprotal → kann auch anonym einen Eintrag machen, wenn man Fehler beobachtet hat, normalerweise trägt man Fehler aber selber ein
- Bei MAG wird dieses Fehlerprotokoll nicht berücksichtigt → es kann nicht auf Person zurückgeschlossen werden → ist anonym
- Stürze werden besprochen, aber nicht auf Pflegefachkraft bezogen.
- Vor jeder Schicht gibt es Einsatzbesprechung: wo Arbeitsplan, Probleme, Ziele besprochen werden → Stationsleitung und Pflegefachkräfte sind dabei (auch die von vorherigen Schicht sind dabei) -> muss nicht überzogen werden von der Arbeitszeit her, sondern ist überlappend

Unfälle, Stürze, … muss erfasst werden, z.B. gibt es ein Sturzprotokoll → muss von Pflegefachkraft selber erfasst werden (unter anderem muss man dokumentieren, was vorher für Sicherheitsmassnahmen gemacht wurde, welche Schuhe der Pat. trug,…) → ist elektronisch

Es wird alles elektronisch gemacht, nichts auf Papier

Jeder hat Zugang zu einem PC → jeder hat eigene e-mail-Adresse

Persönliche Ziele:

- Patientenbetreuungszahl muss erreicht werden → 5 Patienten pro Schicht
- Von Schule aus Ziele, die erreicht werden müssen: können sehr individuell interpretiert werden
- Arbeitskollegen haben MAG, aber keine spezifische Ziele → Ziele schwer messbar

MAG:

- Einmal pro Jahr
- Keine klaren Ziele werden definiert
- Entwicklungsziele werden vereinbart, wenn etwas nicht gut ist
- Ziele zu überprüfen gehört zum Aufgabenbereich der Stationsleitung

Vergütung:

- Fixgehalt

- Bonus: von Stationskasse wird ausbezahlt (Stationskasse = Geld von Patienten → Trinkgeld) → wird sonst normalerweise für Teamausflüge etc. verwendet
- Gehaltsschema: Gehaltsaufstieg durch Tenure und Ausbildung → wahrscheinlich gesetzlich definiert, KH weiss dies nicht genau
- Zufriedenheit mit Gehalt: ist tief → es herrscht allgemeine Unzufriedenheit mit dem Gehalt. Man trägt sehr viele körperliche Schäden davon, Gehalt wird mit dem von Ärzten verglichen

Weiterbildungen:

- Wird vom Arbeitgeber stark gefördert
- Pflegeexperten machen Themenwochen, Weiterbildungen,…
- Wird vom Spital bezahlt: Arbeitszeit und Kurskosten
- Keine Vorschriften, dass man Weiterbildung machen muss
- Gibt viele Pflegefachkräfte, die nicht an Weiterbildungen interessiert sind

Daten, die erhoben werden:

- Nach jeder Schicht wird die Zufriedenheit des Personals erfasst
- Es gibt Tafel wo alle Patienten darauf sind. Muss nach jeder Schicht die Arbeitsbelastung nach hoch, niedrig, mittel bewerten
- Patientenzufriedenheit wird auch bewertet: wird aber nicht bei Patienten nachgefragt, sondern von Pflegefachkraft eingeschätzt
- Diese Einschätzungen der Arbeitslast wird an Stationsleitung weitergegeben
- Es wurde nicht so miterlebt, das etwas aufgrund der Arbeitslast gemacht wurde
- Pflegefachkräfte hoffen darauf, dass der Stellenschlüssel angepasst wird → das mehr Personal eingestellt wird.
- Patientenstürze,…
- Patientenzufriedenheit wird nicht direkt erfasst → Rückmeldungen gehen direkt an Zentrale des Spitales → wird durch Broschüren auf Nachttisch in den Zimmern ermöglicht
- Nur unzufriedene Patienten geben Feedback → Selektion

Abteilungsbesprechungen:

- Teamsitzung einmal im Monat: Teamsitzung mit ganzen Team (auch wenn man frei hat muss man kommen) → ohne Ärzte
- Hudles: vor jeder Schicht

Stressoren:

- Zeitdruck
- Wissen, ich könnte es viel besser machen, aber ich habe zeitliche Ressourcen nicht
- Feedback von Patienten kann nicht umgesetzt werden

- Zusammenarbeit wird schlechter durch Zeitdruck → man hilft einander nicht → gibt Unzufriedenheit
- Patientenleiden löst wenig Stress aus, am lernt früh damit umzugehen
- Gibt häufig, dass man in Konflikte mit Arzt kommt
- Clinical Nurse, etc. sind medizinisch sehr gut ausgebildet. K.H. meint, sie sein medizinisch auch sehr gut ausgebildet
- Ärzte haben das Sagen, Pflegefachkräfte haben eher Patientensicht, da sie mehr Zeit mit ihnen verbringen. Ärzte sehen nur Diagnosen und Laborwerte → sie sehen den Patienten nicht
- Zweite Hauptstressquelle ist Konflikte mit Ärzten, aber auch untereinander im Team
- Nervige Patienten sind nebensächlich, ist nach Schicht wieder vergessen

Stationsleitung:

- Übt nicht viel Druck aus
- Es lastet eher viel Druck auf Stationsleitung → sehr viel läuft über Stationsleitung und sie möchte alles recht machen
- Nicht autoritär

Zufriedenheit wird bestimmt durch:

- Anerkennung von seitens Patienten, Stationsleitung, Berufsbildung
- Team: Teamgeist auf Stationen ist sehr gross im Vergleich zu anderen Berufsgruppen
- Patientenzufriedenheit
- Leistungsdruck durch schlechtes Befinden der Patienten senkt Zufriedenheit
- Wenn jemand am Sterben ist, löst dies auch Stress aus

Frustrationen:

- Zeit
- Unzufriedenheit von Mitarbeiter → raise to the bottom → zieht sich gegenseitig runter → wenn andere unzufrieden sind, ist man auch unzufriedener
- Wissen, wie man es ideal machen könnte vs. Wie man es machen muss
- Mitarbeiter, die nur ihre Checklisten abarbeiten, aber nichts mehr machen («dienst nach Vorschrift») → Gerechtigkeit
- Gerechtigkeit auch grosses Team auf Station: wer hat wie viele Patienten, wer ist wieviel krank

Kündigungsabsichten:

- Keine
- Sie kann es nachvollziehen → Hauptgrund ist Stress und Zeitdruck
- Schichtarbeit ist belastend, vor allem für Sozialleben

Schichtarbeit:

- gibt Personen, die nur Nachtschicht macht, wird so akzeptiert, weil Nachtdienst nicht beliebt
- keine Möglichkeit, nur Tagdienst oder Spätdienst zu machen
- überall so, dass man jedes zweite Wochenende arbeiten muss
- man hat jeden Monat 4 Tage für Freiwünsche
- gibt sehr viele, die 80-90% arbeitet, fast niemand arbeitet 100%

Interview 3

SL arbeitet auf der Intensivmedizin

SL arbeitet seit 1986 als Pflegefachkraft, seit 2008 auf Intensivstation, vorher auf Chirurgie im Spital ABC

Ausbildung: 1986 Spitalgehilfin (Dipl. Pflegefachfrau), dann in Psychiatrie: dort 3-jährige Ausbildung zu Psychiatrieschwester.

Ausbildung seit 2010: dipl. Intensivpflegefachfrau (Nachdiplomstudium, NDS)

Arbeitet 80% im Inselspital mit allen Schichten (Tagdienst, Spätdienst (am Abend) und Nachtdienst), ausserdem auch Wochenenden
2-3 Wochenende (beide Tage) pro Monat wird durchschnittlich pro Pflegefachkraft gearbeitet. Nachtschicht: wenn man 100% angestellt ist, muss man 6 Nächte machen, 80% 4 Nächte

Intensivmedizin hat 4 Teams. Diese Teams rotieren, damit sie alle 4 Stationen betreuen (Abwechslung). Blau: Langliegerpatienten (Patienten mit längerem Aufenthalt) mit Licht / gelb: kein Tageslicht, grün: ohne Beatmung (auf gelb und blau haben die Patienten eine Beatmung)

Pro Teams sind ca. 40 Leute. Hierarchie dort: Teamleiterin und Stellvertretung. Gibt pro Team 4 Personen, die Zonenleitung, Management machen. Dipl. Expertinnen intensivpflege (grosse Mehrheit vom Team), Personen in Weiterbildung (sind dipl Pflegefachfrau und machen jetzt noch NDS), pro Team 1-2 FaGes.

Übergeordnete Leitung ist die Pflegedienstleitung (PDL) der Intensivstation (Matthias Theis). Direkte Vorgesetzte ist die Teamleiterin
MAG findet mit Teamleiterin statt

Motivation für Pflegeberuf:

- Bereits Faszination als Kind da (schon über 30 Jahre her)
- Sieht Arbeit als Berufung

Motivation für Arbeit:

- Behandlung von Patienten → sieht direkt Einfluss, den man mit Arbeit machen kann (impact)
- Mithelfen, Leben zu retten
- Wohlbefinden für andere Menschen machen

Aufgabenbereich:

- Betreut 1-2 Patienten pro Schicht (im Vergleich zu anderen Abteilungen viel weniger, da auf der Intensivmedizin die Patientenbetreuung viel anspruchsvoller ist)
- Beatmungsmaschine, die von S.L. gemanagt werden muss
- Werte, Apparate beurteilen (Blutdruck,…)
- Trends (Aufzeichnungen) anschauen und beobachten, ob spezielle Entwicklung → Interpretation davon und Rücksprache mit Arzt (Arzt ist immer zu gewissen Patienten zugeordnet)
- Körpertemperatur, Haut, Wachheitszustand mit Arzt besprechen
- Sehr breites Spektrum
- Patienten können von Anforderungen her sehr variierten (sehr heterogen)

Beziehung zu Arzt:

- Arzt eher Kooperationspartner, wird nicht als Vorgesetzter gesehen
- Arzt hat Verantwortung für Behandlung, die S.L. ausführt
- Arzt hat mehr Pat. als Pflege, daher kann man als Pflegefachperson auch Empfehlungen etc. abgeben, weil man besseres Bild vom jeweiligen Patienten hat
- Keine starke Hierarchie in dieser Beziehung
- Konflikte mit Ärzten gibt es schon, gibt es aber auch unter den Pflegende
- Konflikte kommen eher selten vor

Regeln:

- Regeln werden nicht von Teamleiterin festgelegt
- Pflegeexpertinnen legen Regeln fest (solche, die nur für Prozesse verantwortlich sind → machen Schemas etc.) → diese sind direkt in der PDL angesiedelt.
- Pflegeexpertinnen begleitet auch Studien → machen Schemas und erarbeiten Anleitungen für Maschinen etc.
- Anleitungen existieren sehr viel
- Für jedes Gerät gibt es eine Beschreibung → wird von den Pflegeexpertinnen geschrieben
- Für Arbeitsschritte gibt es ebenfalls klare Anleitungen → z.B. Angehörigentelefonat gibt es Ablaufanleitung
- Gibt Antrittskontrolle für einzelne Behandlungen → diese Anleitungen werden auch von Pflegeexpertinnen geschrieben
- Mitarbeiterinnen halten sich an Regeln → weil dies einem Sicherheit gibt
- Regeln werden von allen als positiv wahrgenommen → Sicherheit
- Bei Körperpflege, Lagerung, etc. gibt es mehr Freiheit → ist individueller
- Es wird sehr viel mit Maschinen gearbeitet (Beatmung, Dialyse, Überwachungen,…)
- Technische Kompetenz ist in ihrem Beruf sehr sehr wichtig

Organisationsstruktur:

Teamleiterin ist PDL unterstellt

Identifikation:

Identifikation mit Spital BDE, aber schon im Speziellen mit der Intensivpflege → Identifikation mit Abteilung ist etwas stärker

Abweichungen von Regeln:

- Starke Abweichung gibt ein Gespräch. Kleine Abweichungen eher nicht
- Bei Schwerwiegenden Dingen (z.B. nicht kompatible Medis zusammen verabreichen) gibt es Gespräch mit Teamleiterin (oder direkt mit jeweiligen Schichtleiterin)
- Schichtleiterin ist eine von den Pflegenden (Tagdienst sind 7 Pflegende und eine von den 7 hat die Leitung für die anderen 6 Pflegenden) Sie hat die Verantwortung für die Pflege. Zonenbetriebsleitung hat die Überverantwortung über alles
- Abweichungen werden sanktioniert
- Abweichungen kommen eher selten vor

Freiräume

- Für Körperpflege und Lagerung gibt es Freiräume
- Beatmung umstellen ist auch möglich → wenn man Kriterien am Patienten abschätzen kann, kann man mit Rücksprache mit Arzt Beatmung ändern (kann dies auch erst nachträglich mit Arzt besprechen)
- Noradrenalin: z.B. sagt Arzt, dass man dies Ausschleichen soll, kann als Pflegefachperson selber bestimmen, wie schnell dies geht
- Freiräume werden sehr geschätzt von S.L.

Dokumentation:

- Es wird alles dokumentiert, was gemacht wird
- Bei den Maschinen läuft die Dokumentation automatisch ab
- Gibt Verpflichtung dazu, dass man Trends immer kontrolliert und Interpretation dokumentiert

Individuellen Kennzahlen:

- Bei Langliegenden ganz klare Ziele (Pflegeplanung)→ weiss, was man zu tun hat: gibt Tafel im Patientenzimmer mit Pflegeplan → dies muss eingehalten werden. Wenn man es nicht einhält, muss dies dokumentiert werden
- Ziele hängen vom Patienten ab und weniger von Pflegefachkraft

MAG:

- Einmal im Jahr
- Beide (Vorgesetzte und Angestellte) gehen vorbereitet ans MAG: Selbsteinschätzung von S.L.
- Gibt Blöcke: Soziale Kompetenz (Teamverhalten etc.), Fachliche Kompetenz (spezielle Fähigkeiten etc.) ,

- Gibt Skala von A-D als Bewertung
- Ziele für das nächste Jahr von S.L müssen definiert werden
- Ziele vom Vorjahr werden besprochen: letzte Ziele von S.L.:
    - Einführung von FaGe (ist neu so: durch Spardruck wurde pro Team Dipl. Pflegefachperson durch FaGe ersetzt → ist zuerst auf Widerstand gestossen)
    - Hygiene: Hände desinfizieren etc.
    - Egmo (Herzlungenmaschine): S.L. musste Anleitung dafür schreiben
- Einschätzung der Vorgesetzten: sie arbeitet im Team selber im Team mit und kann dadurch eine bessere Beurteilung abgeben
    - Hygiene wird durch Hygienevisite überprüft
    - Egmoschulung: klares Resultat zu sehen, dass man beurteilen kann
    - FaGes ist schwerer zu beurteilen → qualitativ
- Entwicklungsmassnahmen: ist stark präsent im Gespräch → Weiterentwicklung wird von Vorgesetzter gewünscht und betont

Kennzahlen:

- Mortalitätsraten werden ausgezeichnet
- Durchschnittliche Aufenthaltsdauern
- Kennzahlen werden von Ärzten und Pflegeexpertinnen erhoben, Pflegefachkräfte werden dann darüber regelmässig informiert
- Anzahl Egmo-Einlagen → wie viele Patienten damit überlebt haben,… / wie viele nach 5 Jahren noch leben
- Wird unterschiedlich oft kommuniziert → ca. 2-3x im Jahr
- Auch Infos zu verschiedenen Studien
- Gibt Newsletter, der Monatlich verschickt wird (über Studien,…)

Ziele:

- Ist Dialog
- Wird nicht von vorgesetzter vorgegeben
- S.L. kann Vorschläge als Ziele einbringen
- Vorgesetzte macht auch Vorschläge
- Anzahl Ziele variiert, mind. 2

Vergütung:

- Bonus: gibt es nicht
- Fixgehalt, keine leistungsabhängige Belohnung
- Gehaltsschema: Vorgesetzte hat Budget, dass sie an Pflegefachkräfte verteilen kann
- Vorgesetzte hat Spielraum mit Lohnverteilung
- Varianz vom Lohn ist nicht viel → Höhe macht nicht so viel aus, eher Anerkennung durch Gehaltserhöhung macht Freude
- Gehaltaufstiegt stellt kein Anreiz dar, sondern die Anerkennung von Erhöhung
- Teamleiterin entscheidet Gehalterhöhung
- Rückstufungen eher selten → kann sein, dass es einfach längere Zeit keine Erhöhung gibt

Zufriedenheit mit Lohn

- SL ist zufrieden mit Gehalt
- Spital EFG: verdient deutlich mehr
- Inselspital ist höher als umgebende Spitäler im Kanton Bern
- Intensivpflege hat höherer Lohn als sonstige Station → man hat MDS → ist Nachdiplomstudium, man hat höhere Qualifikation
- Fast alle, die auf Intensiv arbeiten, haben MDS Diplom

Weiterbildung:

- Ist in letzten 10 Jahren sehr gefördert worden
- Momentan Wechsel vom Chefarzt → ihm ist es weniger wichtig
- Kostendruck löst dies wahrscheinlich aus
- Gesetzlich vorgeschrieben ist nichts →alles auf freiwilliger Basis
- Weiterbildung ist Arbeitszeit (bezahlt) und Weiterbildungskosten werden auch bezahlt
- Früher: Immer Montag, Mittwoch und Freitag ¾ Stunden→ als Spätschicht ging man jede Woche 3x in der Woche in eine Weiterbildung → jetzt gibt es das nicht mehr → jetzt hat man 2x im Jahr eine obligatorische Sitzung à 2h → dort werden Themen bearbeitet, die vorher in Schulungen angeschaut wurden → Qualität ist zurückgegangen
- Vorherige wöchentliche Schulungen waren für Ärzte → jedoch sollte pflege auch dabei sein → Dies löste dann viele Überzeiten aus → neue Chefarzt möchte dies nicht mehr

Wichtige Aspekte:

- Keine
- Ist situationsabhängig

Teambesprechungen:

- 3 im Jahr, eine davon ist obligatorisch: dort wird über Ferien, Neuerungen etc. gesprochen (findet im Januar statt)

Patientenzufriedenheit:

- Gibt keine Fragebögen → Patienten der Intensivmedizin könne sich nicht an Zeit dort erinnern
- Angehörige werden dafür befragt: gibt Tafeln im Aufenthaltsbereich: kann Zufriedenheit, Bedarf etc. dort angeben (auch längeres Feedback möglich)
- Diese Rückmeldungen werden dann auch angeschaut und berücksichtigt

Stress:

- Wenn man alles auf einmal machen muss: wenn mehrere Eintritte auf einmal kommen
- Wenn Team unerfahren (jung) ist → SL hat dann Gefühl, sie muss überall schauen
- Transporte organisieren
- Stress hat sie nicht in dem Sinn
- Patientenunwohlsein/ -sterben: wird nicht als Stressor wahrgenommen, gehört zum Arbeitsumfeld → auf Intensivmedizin geht es den meisten Patienten sehr schlecht Sieht Arbeit als Lösung für dieses Problem
- Lässt sich nicht so schnell stressen: ihrer Meinung nach, muss man einfach das Arbeitstempo erhöhen
- Zeitdruck: eher selten, am häufigsten im Spätdienst
- Stressige Situation: 2 Patienten zugewiesen bekommen, denen es beiden sehr schlecht geht → Eine Patientin davon war am verbluten und Zeugen Jehovas, sie wollte keine Bluttransfusion → SL musste dies Aushalten → dies Hilflosigkeit stresste SL extrem → sind nur Ausnahmefälle
- Sobald sehr grosser Zeitdruck, hilft man im Team untereinander aus
- Teamleiterin ist keine Quelle von Stress
- Konflikt mit Arzt löst auch kein Stress aus → wird als Meinungsverschiedenheit gesehen

Arbeitszufriedenheit:

- Teamarbeit (Teamklima)
- Erleben mit Patienten
- Gutes tun
- Angehörige -> Zufriedenheit von Ihnen
- Anderen helfen können → altruistische Motive
- Wissen → wenn man weiss, wie man Menschen helfen kann
- Entwicklungsmöglichkeiten
- Inhalt der Arbeit → Vielseitigkeit

Frustration:

- Wenn Triage nicht klappt → dadurch entsteht unnötiger Aufwand → z.B. wenn Patient auf Intensivmedizin kommt, der nicht dort hingehört
- Unentschiedenheit über sterben lassen oder weiterhelfen (Patientensterben gehört zum Tagesgeschäft -> stresst SL nicht, gehört zur Arbeit, löst Betroffenheit aus → wirkt dann auch länger nach)

Kündigungsabsichten:

- Krankenhaus möchte sie nicht wechseln

- Beruf aufgeben kommt auch nicht in Frage → hat Beruf kurz aufgegeben, als sie Kinder bekommen hat → hat dann kurz darauf wieder mit der Arbeit begonnen → sie ist sehr zufrieden mit dem Beruf

Interview 4

Notfallpflegefachfrau seit 8 Jahren. Davor stationäre Pflege (Neurochirurgie)

Als Pflegefachkraft arbeitet NW 20 Jahre, mit Ausbildung 25 Jahre Spitalerfahrung

Ausbildung:

Vorschule an DDD für Pflegeberufe, danach halbjähriges Praktikum, dann dreijährige Ausbildung dipl. Pflegefachfrau (heute Pflegefachfrau HF) -> tertiäre Stufe

NW arbeitet 100%, 3-Schichtbetireb mit 8.5h Schichten.
Ca. 3 Nachtdienste pro Monat und 2 Wochenenden pro Monat (jeweils immer beide Tage)

Einspringen:
Auf dem Notfall nicht so oft, da dort sehr voller Stellenplan
NW springt ca. 3x im Jahr ein
auf anderen Abteilungen anders: hat sehr viel mit Stellenplan zu tun
Notfall ist eine unabhängige Klink, es kommt nie jemand von anderer Klinik (einspringen)

Motivation für Pflegeberuf:

- Zufall
- Als Kind wollte NW nie Pflegefachfrau werden

Antrieb:

- Befriedigende Arbeit
- Unmittelbar
- Sichtbar → sieht Impact
- Nicht Hilfe wird von NW wertgeschätzt, sondern Unterstützung / Begleitung von Patienten
- Altruistische Motive
- Zusammenarbeit mit Menschen
- Fassbar → nicht abstrakt

Hierarchie:

- Vorgesetzte ist Pflegedienstleitung (PDL)
- NW ist Stationsleitung
- Im Notfall gibt es eine PDL
- Hierarchie: PDL → Stationsleitung → Pflegekräfte
- PDL untersteht dem Chefarzt der Klinik

Politisch korrekte Ausdruck: Pflegefachpersonal

Geschlechtermix: viel mehr Frauen → Im Notfall tendenziell mehr Männer als bei anderen Abteilungen

Aufgabenbereiche:

- Führungsaufgaben (40% ihres 100%-Pensums)
- Versorgung der Notfallpatienten (60% ihres 100%-Pensums)–> Flach hierarchisch organisiert mit ärztlichem Dienst → gibt sehr viel Freiräume
- NW arbeitet normal mit Pflege zusammen (hat dieselben Kompetenzen)
- Pflegeaufgaben:
    - Technische Verrichtungen: Infusionen, Blutentnahme, Wunde versorgen
    - Krisenbegleitung –> Notsituation
    - Gespräche führen
    - Nicht klassische Pflege: kein Waschen etc. , da kurze Verweildauer von Patienten (durchschnittlich 4h)

Kann nicht gesagt werden, wie viele Patienten NW pro Schicht betreut → kommt auf Schweregrad vom Zustand des Patienten an → Anzahl Patienten sagt nicht aus über die Arbeitslast

N.W. hat Doppelrolle:

- Führt MAG
- Hat ihr MAG mit PDL

Identifikation:

Mit Abteilung statt mit Inselspital

Arbeitsumfeld:

Verhaltensrichtlinien, Regeln:

- Handlungsleitende Dokumente: dort sind wichtige Sachen ganz klar geregelt
- Checkliste: bei Todesfall und bei Austritt (z.B. interne Verlegung), dies ist dann automatisch in Dokumentation integriert
- Dokumentation erfolgt vollständig digital
- Richtlinien werden nicht als einschränkend vorgenommen: es sind nur Dinge geregelt, die geregelt sein müssen, weil sie gefährlich, etc. sind → wird positiv als Orientierungshilfe wahrgenommen

- Abweichung von Richtlinien kommt vor: wenn man in der Hektik die Arbeit nicht genau so macht wie in Richtlinien vorgeschrieben → wird aber sofort bemerkt durch gegenseitige Kontrolle
- Gegenseitige Kontrolle zw. Pflege und ärztlicher Dienst --< man arbeitet stark im Team zusammen
- Pflege kritisiert oftmals auch ärztlicher Dienst
- In Notfallpflege ist gegenseitige Kontrolle sehr wichtig

Freiräume:

- Schweizer Pflegesystem: als Pflege ist man viel angesehener als in z.B. Deutschland → hat viel mehr Verantwortung und Kompetenzen
- Z.B. wenn Pat. Schmerzen hat, kann man ihm direkt Medikament geben und dies Arzt später berichten
- Alle auf Notfall haben dieselben Kompetenzen → diejenigen, die Weiterbildung in Notfallpflege haben, dürfen noch mehr ausführen

Kennzahlen:

- Gibt ganz viele
- Verweildauer
- Dauer bis der Arzt Pat gesehen hat ab Eintritt
- Wie viele stationäre und ambulante Verlegungen/Austritte
- Pflegezeit wird mit bestimmtem System abgerechnet (tacs-Punkte): daraus wird abgeleitet, wie viele Pflegende eine Station zur Verfügung
- Es gibt für alles eine Kennzahl
- Ziele basierend auf diesen Kennzahlen gibt es nicht → man erhält keine Kennzahlen. → aber Rückmeldung dazu erhält man
- Alle Mitarbeiter haben Zugang dazu: werden publiziert → es werden aber nur Zahlen publiziert, zu denen man einen Bezug hat → wird einmal im Jahr an Teamsitzung publiziert → wird mit Vorjahr verglichen und dann werden Ziele davon abgeleitet

Sitzungen

Teambesprechung: 4x pro Jahr (bei 130 Mitarbeitenden nicht möglich, dass immer alle daran teilnehmen)
mit verschieden spezifischen Berufsgruppen: Triagesitzung 2x im Jahr, Schichtleitungsssitzung 1x im Jahr

MAG Ablauf:

- Gibt vorgegebene Formulare
- Skala von A-E

- NW ist es wichtig, dass sie im Austausch ist mit den Mitarbeiter → Sie füllt die Skala A-E nicht aus, da sie es als Schulnote sieht → ihre Mitarbeiter sind selber so gut reflektiert, dass sie selbstständig auf Punkte kommen, bei welchen sie sich verbessern können
- Sie sieht sich als gute Führungsperson, wenn sie das Problem sofort klärt und nicht erst am MAG, welches nur einmal jährlich stattfindet
- Ziele: ist Mitarbeiterabhängig → bei Langjährigen: z.B. Ziel eine Weiterbildung zu besuchen, wenn jemand bereits 30 Jahre in Pflege arbeitet, sind «anfängerziele» nicht sinnvoll
  bei neuen Mitarbeitern ist spezifische Zielsetzung nötig: z.B. Hauptfokus auf Herzerkrankungen setzen etc.
- Es werden nie mehr als 3 und nie weniger als 2 Ziele formuliert
- NW hat an ihrem eigenen MAG auch Ziele
- Ziele werden immer gemeinsam formuliert → werden von beiden Seiten vorbereitet -> am MAG sieht man dann oftmals, dass dies gut zusammen passt.
- → interaktiver Prozess
- Ziele werden ohne Rücksprache gegeben, wenn es gefährlich wird, wenn jemand Aufgaben falsch ausführt

Vergütung:

- 300.- Gefahrenzulage, wird von Klinik bezahlt → ist unabhängig von Grad der Leistung
- Sonst keine Bonuszahlungen

Gehaltsschema:

- Gehaltsaufstieg: von Konzern wird Prozentsatz vorgegeben, dies wird dann auf Klinik hinuntergebrochen → erhält Budget, das einem für Lohnerhöhungen zur Verfügung steht → dieses Jahr wurden 11'000 CHF für alle Mitarbeitenden, die NW unterstellt sind (46 Personen), gegeben
- In Spital ADE Regel, dass man Mitarbeiter nicht von anderen Kliniken abwerben darf: man darf nicht mehr Lohn bezahlen als auf anderer Klink → daher gibt es extremes Lohngefälle (bei Neuanstellungen darf man viel höheren Lohn bezahlen)
- Das Budget für Gehaltserhöhung wird genutzt, um dieses extreme Lohngefälle auszugleichen
- Teuerungsausgleich existiert, ist minim

Zufriedenheit mit Gehalt:

- NW ist zufrieden damit → jedoch in Privatwirtschaft würde niemand 46 Mitarbeitende führen mit ihrem Lohn

Lohngerechtigkeit:

- Im Team sehr grosses Thema
- Innerhalb des Teams wird stark verglichen
- Mit Privatwirtschaft wird auch stark verglichen

- Es sind alle zufrieden mit ihrem Lohn, aber im Verhältnis mit der Privatwirtschaft wird es als tief gesehen
- Lohn ist Quelle von Frustration

Weiterbildungen:

- Ist nicht gesetzlich vorgeschrieben
- Leitet sich aus Ziele des MAGs ab
- Im Notfall gibt es obligatorische Weiterbildung (von Klinik vorgeschrieben)
- 1x im Jahr interprofessionale Weiterbildung
- Alle 5 Jahre muss man Reanimationstraining machen
- Alle Mitarbeiter haben 3 Tage Weiterbildung zu Gute (3 bezahlte Arbeitstage, Weiterbildungen dürfen nicht mehr als 500.- kosten bei einer 100% Anstellung)

Besondere Aspekte:

- Sicherheit
- Transparenz
- Von PDL: dasselbe

Für Dokumentationssystem beim Notfall gibt es Applikationsverantwortlichen (IT-Verantwortlicher). Dort kann NW Kennzahlen verlangen. Sie macht dies oftmals, um etwas belegen zu können (wenn etwas von ihr verlang wird oder wenn sie jemandem etwas aufzeigen will) → dient ihr als Informationsgrundlage

Stressoren:

- Grosses Patientenaufkommen und Abflussproblem (man wird Patienten nicht los)
- Notfall ist nicht steuerbar → es gibt sehr grosse Unsicherheit: kann sein, dass 2h nichts passiert und auf einmal kommt alles gleichzeitig → gar nicht planbar
- Es ist offensichtlich, was das Problem ist, man kann es aber nicht lösen, da der Prozess so umständlich ist (Spital ADE ist so organisiert, dass jede Klink separat organisiert ist → Verlegungen etc. werden schwierig)
- Stress wird hauptsächlich durch den komplizierten organisatorischen Prozess ausgelöst → man könnte es sehr einfach machen aber es ist kompliziert geregelt
- Im Notfall ist eine hohe Stressakzeptanz → wenn man nicht stressresistent ist, kommt man nicht auf den Notfall arbeiten –> jeder neue Mitarbeiter ist am Anfang überfordert: fachlich alle Themenberieche, Stressaufkommen, … → wenn man das erste halbe Jahr «überlebt», bleibt man und wird stressresistent
- Stress ist täglicher Begleiter
- PDL ist keine Stressquelle

Konflikte mit Ärzten:

- Es gibt fix angestellte Oberärzte: mit denen fast nie Konflikte -> kennen Abläufe auf dem Notfall
- Fix angestellte Assistenten: keine Probleme → kennen Abläufe auf dem Notfall
- Rotationsassistenten: mit denen gibt es viele Konflikte: sie sind sich Notfallarbeit nicht gewohnt → man muss sie «sozialisieren»
- Zusammenarbeit mit Ärzten ist auf Augenhöhe → ist keine Stressquelle
- Stressquelle: bei neuem Oberarzt: NW hat viel mehr Erfahrung aber Oberarzt ist in Hierarchie höher → Problem wird durch Diskussion gelöst
- Pflege und Ärzte sind aufeinander angewiesen

Kündigungsabsichten:

- 15 Jahre lang hat sie in EEE gearbeitet
- Keine Kündigungsabsichten momentan
- Jetzt Spital ADE: «Topliga»
- NW hat das Gefühl, sie kann nur absteigen → Notfall ist interessanteste und anfordernde Anstellung
- Zukünftig ev. Bedürfnis nach weniger Stress
- Intensivmedizin ist mit Notfall vergleichbar (von Komplexität her)
- Reputation von verschiedenen Berufsgruppen ist ganz anders → Notfall weniger angesehen als Intensivstation
- Andere Abteilungen sind von Komplexität her weniger anspruchsvoll → von Pflegerischer Seite ist es aufwändiger, aber nicht komplex

Fluktuation: unterschiedlich → letztes Jahr war sie sehr hoch bezüglich der Notfallstation

Auf dem Notfall sind 2 Jahre Berufserfahrung notwendig, danach macht man meistens noch Weiterbildung zur Notfallpflegefachperson → dann bleibt man dem Beruf treu, da so grosser Aufwand, diese Position zu erreichen

NW kann sich ganz anderen Beruf als Pflegefachfrau vorstellen, jedoch wird sie dies nicht umsetzen. Ev. wird sie mit dem Alter auf eine andere Station gehen

Interview 5

Abteilung UDEM (Universitätsklinik Diabetologie, Endokrinologie, Ernährungsmedizin und Metabolismus), Anstellung seit 12.2018

NS war vorher auf dem Notfall angestellt. In UDEM gibt es geregelte Zeiten (keine Wochenendarbeit, kein Spätdienst), daher hat sie sich entschieden auf UDEM zu arbeiten → ist einfach um Familie und Arbeit zu vereinen
UDEM: ist ambulanter Betrieb
Arbeitszeiten bei UDEM: nur Tagesschicht von 08:00- 17:10

Einspringen
Beim Notfall musste sie oftmals aushelfen → dabei wurde allg. SMS verschickt und man konnte freiwillig entscheiden, ob man einspringen will
Abteilungswechsel auch häufig (aber nicht auf Notfall wegen speziellen Bedingungen dort) → ist nicht sehr beliebt

NS arbeitet Teilzeit zu 60%

NS arbeitet seit 15 Jahren als Pflegefachkraft. Vorher einige andere Stationen

Ausbildung:

4 Jahre, verschiedene Praktika inkl. → Blockweise Praktikum und Schule während Ausbildung

Motivation für Pflegeberuf:

- NS arbeitet gerne mit Menschen zusammen
- Sie wollte ursprünglich Lehrerin werden
- Danach Kinderkrankenschwester → beim einwöchigen Schnupper-Praktikum hat sie herausgefunden, dass sie dies nicht kann, da ihr die Arbeit mit kranken Kindern zu nahe geht. Schwere krankheitsbedingte Situationen der Kinder belasten sie zu sehr
- Umfangreich: administrativ, praktisch, hat häufig lernende → Variation

Motivation bei der Arbeit:

- Nicht voraussehbar → kein strukturierter Ablauf
- Abwechslungsreich
- Man muss selber Prioritäten setzten
- Bei UDEM oder Notfall hat begleiten nicht so einen grossen Stellenwert wie auf einer Onkologie-Station. Dies würde NS wieder zu nahe gehen, da dort das Thema Tod stark im Zentrum

Korrekte Bezeichnung: Pflegefachperson

Hierarchie:

PDL → Teamleiterin → Team (dipl. Pflegefachfrauen, FaGes, MPAs), in ihrem Team sind 9 Personen
NS führt die MAGs, ihr MAG führt mit ihr die PDL

Aufgabenbereiche:

- Vielfältige Tätigkeit, weniger als auf dem Notfall im UDEM
- Blutentnahme, Infusionstherapie, Injektionen, Instruktionen
- Technische Geräte eher selten → in UDEM ist Infusomat das einzige

Anteil Führung-Pflegearbeit

- 20% von zuhause administrativ
- 40% Pflege

Verhaltensvorschriften:

- Gibt von verschl. Stellen Vorgaben
- Vorgaben werden von ganzer Unternehmung gestellt
- Innerhalb definierter Grenzen hat NS Bewegungsspielräume
- Vorschriften werden positiv gesehen → sind notwendig für das Funktionieren der Unternehmung, jedoch könnte man gewisse Regeln ändern und funktionaler gestalten

Checklisten:

- Bei Tests werden diese immer verwendet → gibt Vorlagen in System
- Gibt auch zu anderem Checklisten

Dokumentation:

- Das meiste ist dokumentiert
- Wird als mühsam wahrgenommen → benötigt viel Zeit
- In UDEM muss weniger dokumentiert werden als bei anderen Stationen (da man z.B. weniger Pflegearbeit leistet und dadurch der Pflegebericht wegfällt)

MAG:

- Einmal im Jahr

- PDL hat bisher MAGs gemacht → dabei wurden Ziele vereinbart (1-3 Ziele)
- In Zukunft wird NS die MAGs mit Team machen
- Ziele werden auf Augenhöhe gemacht, werden nicht vorgegeben
- Auch zwischendurch wird oftmals ein Gespräch gemacht → ist Prozess → auf dies legt NS grossen Wert → vorzu Verbesserungen vorschlagen und nicht nur einmal im Jahr am MAG
- PDL: untersteht dem Klinikdirektor
- Bewertung: Skala A-E und zusätzlich werden Ziele definiert
- Diese Ziele sind unabhängig, ist personenbezogen
- MAG hat Entwicklungscharakter, viele empfinden dies jedoch nicht so
- Man muss ich vorbereiten anhand Selbsteinschätzung und Feedback an Vorgesetzte

Identifikation:

Kann sie noch nicht sagen, da sie noch nicht lange hier arbeitet

Freiräume: gibt viele in UDEM

Kennzahlen:

- Kein Zugang zu Kennzahlen
- Kennt sich da nicht gut aus

Ziele:

- Konkret definiert → sind messbar
- Z.B. Offenheit für Neue Dinge, Innovativ sein, Änderungen akzeptieren

Innovation:

- Pflegepersonal kann sich darin einbringen
- Jedoch wird dabei Zurückhaltung wahrgenommen
- Änderungen oftmals nicht erwünscht, da konservativer Charakter da
- In UDEM wird Innovation nicht sehr gut angenommen
- Auf einer anderen Station ist die Struktur viel komplexer
- Es gibt eine Pflegeexpertin auf UDEM → diese bring jedoch nicht viel Innovation in ihre Arbeit
- Bei aktiver Pflegetätigkeit sind Innovationen nicht gut möglich
- Handlungsanweisungen oder Standards könnten angepasst werden
- Vorschläge für Innovationen werden nicht angenommen, es wird nicht ausprobiert

Vergütung:

- Kein variabler Bestandteil
- Bonus bekommen nur Ärzte
- Nur Festgehalt

Gehaltsschema:

- Gehaltserhöhung: PDL hat Möglichkeit dazu, NS kann Empfehlungen dafür abgeben

Zufriedenheit mit Lohn:

- In UDEM ist man nicht sehr zufrieden mit Gehalt
- Beim Vergleich mit Bürojob wird es als unfair wahrgenommen

Gegenseitige Kontrolle im Team:

- Nicht sonderlich vorhanden in UDEM

Stressquellen:

- NS empfindet kein Zeitdruck
- Bei Klinik UDEM keine Stressquellen, da sie sich Notfallpflege gewohnt ist
- NS mag stressige Situationen
- In stressigen Situationen wird Zusammenarbeit sehr wichtig → gegenseitige Überwachung etc.

Weiterbildung:

- Pflege hat Möglichkeit immer von 16:30-17:00 bei Ärzten an Sitzung zu sein und fragen etc. zu stellen → wird jedoch nicht genutzt
- Spital bezahlt auch Weiterbildung, wenn es dem Betrieb etwas bringt
- Gibt keine Vorschrift, wie viele Weiterbildungen man machen muss

Wahrnehmung der PDL:

- Innovativ, drückt sich deutlich aus
- Arbeitet nicht in Pflege mit
- PDL übt kein Druck auf NS aus
- Fragen sind willkommen

Datenerhebung:

- Wird vom Controlling erhoben, NS hat keinen Zugang

Sitzungen:

- Teamsitzung: alle 2 Monate
- Ein- Zweimal im Jahr trifft sich ganze Klinik → dort wird Status quo und Zukunft besprochen → Ferienbesprechung, Infos werden abgegeben zu Änderungen etc. / über Kennzahlen oder Daten wird dort nicht gesprochen

Zusammenarbeit mit Arzt:

- Ärzte haben das Sagen, Verantwortung liegt bei Ihnen, daher wird nicht gross diskutiert

Schwierige Situationen lösen bei NS Stress aus → bei Konfrontation mit Tod oder Kinderleid kann sich nicht gut umgehen

Zufriedenheit wird ausgelöst durch:

- Wenn NS merkt, dass sie gebraucht wird → Mehrwert stiften
- Etwas Neues einbringen, etwas umsetzten
- Etwas aufbauen
- Wenn man Handlungsergebnisse sieht

Unzufriedenheit:

- Unzufriedenheit der Mitarbeiter: wenn jeder nur noch kritisiert, herumnörgelt → wenn Teamklima schlecht ist

Kündigungsabsichten:

- Keine Absicht den Beruf zu wechseln
- Abteilungswechsel: hat sich so ergeben, nicht aufgrund Unzufriedenheit